

《自闭症线上社区主题与身份分类手册》

目录

1 分类目的与说明	3
2 身份分类规则	3
2.1 患者	3
2.2 患者家属	4
2.3 相关商业从业者	4
2.4 其他	4
3 百度贴吧主题分类规则	5
3.1 分享	5
3.1.1 案例分享	5
3.1.2 科普	6
3.2 寻求帮助	6
3.2.1 自闭症症状	6
3.2.2 自闭症检查	7
3.2.3 自闭症诊断	7
3.2.4 病因/诱发因素咨询	8
3.2.5 费用与经济负担咨询	8
3.2.6 自闭症干预	9
3.2.7 自闭症资源推荐（评价）	9
3.2.8 其他求助	10
3.3 广告	10

3.4 表意不明	11
3.5 其他	11
4 春雨医生、好大夫主题分类规则	11
4.1 自闭症症状	12
4.2 自闭症检查	12
4.3 自闭症诊断	13
4.4 病因/诱发因素咨询	13
4.5 费用与经济负担咨询	14
4.6 自闭症干预	14
4.7 自闭症资源推荐（评价）	15
4.8 其他求助	15

1 分类目的与说明

本分类手册旨在对中国主流在线自闭症相关社区中的用户生成内容进行系统化主题与身份标注。适用平台包括开放式论坛平台（如百度贴吧）以及在线医疗问诊平台（如春雨医生、好大夫在线）。分类结果用于后续的主题分布分析、跨平台比较及 LLM 辅助标注框架的有效性评估。

本分类手册同时适用于人工标注与大语言模型（DeepSeek）辅助标注两个部分。在开放论坛平台中，分类单位为单条帖子，仅包含发帖者发布的主楼文本，不含回帖。每一个分类单位仅对应一个一级主题与一个二级主题。在医患咨询平台中，一次医患咨询可能包含多个可区分的患者需求，本研究以每个患者需求作为最小分类单位。每一个分类单位仅对应一个主题。

2 身份分类规则

本规则适用于在开放式论坛平台（如百度贴吧）中，根据发帖者的自述内容、语言特征、文本中包含的关键词以及其过往发帖记录中的行为特征，对其身份进行分类。判断方式为：根据该发帖人发布的全部主楼帖子中是否存在具有明确自述性质的强证据（如“我是孩子妈妈”等），是否存在长期稳定的称谓与叙述方式以支持某一身份判断（如“我家孩子”等），以及是否存在与特定身份相关的关键词、用户名暗示或其他身份线索等。

2.1 患者

定义：指患有自闭症的个体本人，以第一人称身份进行发帖，自称为患者本人，分享自身患病经历、相关经验或提出求助；即使文本中未明确出现主语，但整体语境能够清晰判断为在表达个人患病体验或情感的，也归入本类。

关键词：我、自己、自己的经历/经验、我小时候、我以前等。

示例记录：

1. “自闭症 20 多年了！今年 30 了！！还是没好不知道怎么办。”

2. “自闭症大学生自述：给宝宝被诊断的爸爸妈妈们一点希望。”

2.2 患者家属

定义：指自闭症患者的父母、监护人或其他亲属，以家长或照护者身份发帖，自称为家长/监护人/亲属，或通过“我家孩子”“我们家宝宝”“儿子”“女儿”“男宝”“女宝”等表述，叙述患儿的抚育情况、就医经历或提出相关求助。

关键词：我家孩子、我家娃、我家女儿/儿子、女宝、男宝等。

示例记录：

1. “我家是山西的，求北京自闭症康复靠谱的机构。”
2. “求问我家孩子是不是自闭症。”

2.3 相关商业从业者

定义：指发帖者以某康复机构、培训机构或相关服务机构代表身份发言，或属于个体工商户、正在求职的特殊教育从业者等。此类帖子通常包含明显的推广或宣传意图，以机构或从业者身份进行表述；用户名可能为明确的机构名称；发帖目的包括引流、招生、课程推广或付费咨询等商业行为，或包含诱导家长选择特定机构的表述。

关键词：讲座、教授、讲师、儿童训练中心、专业性、机构、托管、康教中心、康复教育、训练中心、加我（联系方式）、星宝上学、优惠、中美星星、欢迎加入，招聘。

示例记录：

1. “自闭症的孩子不愿意上集体课怎么办，千万别强制上课_上海育之星。”
2. “成都特殊儿童全日制托管服务招生信息。”

2.4 其他

定义：包括不属于以上三类中的其他用户，包括志愿者团体官方、公益机构、无盈利意图的公众号等。当文本中不存在明确的自述信息、稳定的身份称谓或其他可靠线索以支持身份判断，且未呈现明显的特征性行为时，不应进行推断性归类，而应统一归入“其他”类别。

示例记录：

1. “新年好。”
2. “[cp]祝天下的母亲节日快乐!祝愿天下的星星们早日回归!”

3 百度贴吧主题分类规则

除数据缺失的帖子外，对其余帖子制定一级主题与二级主题的分类标准。数据缺失包括帖子中因爬取错误出现报错信息（如“'HTTPMessage' object has no attribute 'getheaders'”），以及转发或分享帖中原帖已删除等情况。

主题分类依据帖文的核心发帖意图与内容功能进行判定，主要用于识别用户是在分享信息、寻求帮助、进行商业推广，或因信息不足而无法判断主题。在实际标注过程中，应首先判定一级主题，再在对应的一级主题下细分二级主题。鉴于开放社区的特点，当一条内容同时符合多个主题特征时，应依据发帖者的主要交际意图及其身份进行综合判定。

3.1 分享

该类帖子以主动分享信息、知识或经验为主要目的。发帖者并非以寻求帮助为主要意图，而是向社区提供可供他人参考、传播或复用的内容。

3.1.1 案例分享

定义：指用户主动分享与自闭症相关的个人或家庭实际经历，包括诊断过程、干预经历、教育体验或日常生活记录，具有明确的经验交流性质。仅表示“想谈谈孩子情况”但未提供具体内容的，不归入本类；无明显求助意图，主要目的是分享故事、交流经验或表达个人感想。本类帖子以患者或患者家属为主，通常围绕真实经历或长期过程展开，例如开贴进行阶段性记录与持续更新。其主要目的不在于提问、索取建议或进行营销推广。仅简单说明“孩子有自闭症”但未包含具体经历或过程性内容的，不归入本类。

关键词：我家孩子、我们家、孩子现在、经历、记录、变化、一路走来等。

示例发帖记录：

1. “我家孩子 2 岁 8 个月，因为不会说话，叫他名字不理人，很少跟别的小孩一起玩耍。”
2. “孩子 2 周 3 个月被确诊为疑似自闭症、开贴记录孩子的情况。”

3.1.2 科普

定义：指用户主动分享与自闭症相关的知识性内容，包括相关数据、研究结论、资料、外部链接或图片等，具有公共教育和信息传播属性，但不包含明显的商业推广目的。此类帖子以解释和说明为主，语气相对客观、中性，目的在于向他人传递信息，而非推广具体服务或机构。分享公益活动、科普文章等内容亦归入本类，而不视为广告。

关键词：科普、资料分享、研究表明、知识点、附链接、图片说明。

示例发帖记录：

1. “自闭症并非传染病，也不是遗传病，更不是器质性组织器官病变或者基因突变变异。自闭症是生物界在面临负面思想、思维、逻辑、理解、认知的时候，受负面作用影响达到一定量化积累的时候而产生的自然反应。自闭症属于思想性心理问题，归类于神经系统”
2. “自闭症话说是怀孕时营养缺乏，婴儿时也没补上！”

3.2 寻求帮助

该类帖子以向他人主动寻求建议、信息、经验或具体资源为主要目的。发帖者通常处于困惑、焦虑或需要做出决策的阶段，希望通过社区互动获得支持或指导。

3.2.1 自闭症症状

定义：指患者或家属主要通过描述儿童或患者的具体行为表现、发育异常或日常反应，寻求他人判断这些表现是否异常，或是否符合自闭症相关特征，亦包括询问“自闭症有哪些症状”等问题。该子类关注的核心在于“行为或表现本身是否异常”，而非正式的诊断流程或检查结果。若文本中明确询问“是否为自闭症”

或“如何确诊”等涉及诊断判断的问题，即使同时描述了大量症状，也不归入本类，而应归入“诊断”子类。本类判定的重点在于讨论行为或症状本身，未明确询问诊断流程、量表名称或具体医院。

关键词：不说话、不看人、叫名字没反应、刻板行为、不会交流、行为怪。

示例发帖记录：

1. “孩子两岁多了，基本不和人对视，也不太理人，玩玩具只会自己重复地玩，是不是哪里有问题？”
2. “请问大家叫名不应的宝宝是不是异常好动？”

3.2.2 自闭症检查

定义：指患者或家属围绕自闭症相关的检查项目、评估工具或量表结果提出问题，包括是否需要进行某项检查、如何解读检查或量表结果、完成相关检查后是否可以判断为自闭症，以及检查在诊断过程中的作用。若检查结果仅作为辅助信息，且核心问题在于“是否属于自闭症”这一诊断判断，应优先归入“诊断”子类。本类的判定重点在于讨论检查或量表本身，包括已完成或计划进行的检查，即使最终目的是确诊，但文本重心在检查方式或结果解释。

关键词：检查、量表、ADOS、智测、评估表、测试结果、要不要做检查。

示例发帖记录：

1. “已经做了智力测试和自闭症量表，这个分数说明什么？还需要再做别的检查吗？”
2. “自闭症的宝宝有必要做脑电图和核磁共振吗？”

3.2.3 自闭症诊断

定义：指患者或家属在已有症状描述的基础上，明确围绕“是否为自闭症”这一核心问题进行判断与咨询，涉及自闭症分型、严重程度、诊断可能性、评估结论、诊断流程或确诊路径等内容。当文本同时涉及症状描述与检查结果，但核心问题聚焦于“是否为自闭症”或“应如何确诊（诊断路径）”时，应统一归入本类。包括详细记录孩子的行为表现或发展史，希望获得初步判断或诊断路径建议；或在提供某项检查或测试结果作为辅助信息的基础上，请求判断是否构成诊断；或

询问是否需要进一步检查以明确诊断。

关键词：是不是自闭症、帮忙判断、诊断、怀疑、交流一下、很害怕是不是自闭症、该怎么办。

示例记录：

1. “我家孩子一岁九个月！不会说话一个字都不会说！眼神交流也特别少！但是想吃东西会把东西放在你手里！你说亲亲我会赶快亲亲你！出去玩不怎么和小朋友玩！喜欢上下楼梯！只和自己家里的同龄孩子玩！家里玩玩具喜欢把玩具倒出来再装进去，反复这样！吃东西不会自己用勺子！会用手抓小饼干什么的吃！咀嚼能力好！最喜欢听歌！模仿唱歌人的动作！去医院测试微量元素都没事！请大家帮我看我孩子有自闭症么？还需要做什么检查？”
2. “请各位帮我看我家宝宝是不是自闭症！跪求”

3.2.4 病因/诱发因素咨询

定义：用户围绕自闭症的成因、诱发机制或责任归因提出问题，包括遗传因素、孕期或围产期因素、养育方式、环境暴露等。关注“为什么会这样”。用户关于自闭症的病因、诱发因素等进行咨询。

关键词：遗传、是不是我造成的、孕期、早产、疫苗、二胎、家族史。

示例记录：

1. “求助：脑叶酸缺乏会导致自闭症吗？”
2. “自闭症和小时候吃的奶粉有关系吗”

3.2.5 费用与经济负担咨询

定义：指用户围绕自闭症相关的诊断、治疗、康复或长期干预所涉及的经济成本及支付能力提出问题。本类以“费用本身”为核心焦点，而非比较或咨询具体机构的优劣。凡针对自闭症相关治疗、干预或检查所产生的费用问题进行咨询的，均归入本类。

关键词：费用、贵不贵、花了多少钱、能不能报销、撑不撑得住。

示例记录：

1. “康复一年大概要花多少钱？普通家庭真的承受得了吗？”

2. “宝宝得了自闭症 到残联 想申请些补助 一毛钱都没有得到！！一个月 几千块钱的康复 根本坚持不了”

3.2.6 自闭症干预

定义：指用户围绕自闭症的专业干预方式、治疗路径、训练方法或实施策略提出咨询，包括不同分型或不同严重程度情况下的干预选择，以及干预后的预后效果。本类所指为专业性的训练或康复干预方式，单纯日常生活中的一般性引导不归入本类。此类问题通常反映发帖者对干预效果及未来发展的关注，本质上属于干预与治疗决策层面的咨询。但不包括未涉及具体干预方式，仅泛泛询问自闭症发展影响的问题，如“自闭症严不严重”“自闭症会不会影响以后”等，此类应根据具体语境归入其他相关类别。

关键词：ABA、感统训练、语言训练、家庭干预、训练强度、干预、不知道怎么办、康复手段。

示例记录：

1. “孩子三周两个月上周在医院诊断为轻或中度自闭症，平时能与人对视，喊他也会看你，大小便能自己解决，一些简单的意思也能表达，但是问话经常不回答，总是自己自言自语，去幼儿园上亲子课根本不听老师的话到处乱跑，没有刻板行为，不知道这样的自闭症怎么康复呢，求大神的指导”
2. “如何训练孩子的无对视和叫不应行为？”

3.2.7 自闭症资源推荐（评价）

定义：指用户围绕自闭症相关的诊断、治疗或康复资源，寻求推荐、比较或评价信息。相关资源可以包括医疗机构（如医院、具体科室）、具体医生（包括询问应挂哪个科室），以及康复机构或相关从业人员（如康复教师、语言治疗师、行为分析师等）。其核心在于选择合适的医疗或康复资源，以降低误诊风险或提升干预效果。

关键词：机构、医院、医生、老师等推荐、康复中心、靠谱不、有没有坑、费用。

示例记录：

1. “深圳这边有没有口碑比较好的康复机构推荐？”

2. “求助！天津哪个医院可以做儿童食物不耐受检测？不是过敏源检测。”

3.2.8 其他求助

定义：本类别为兜底类，仅在文本存在明确求助意图，但无法可靠归入任何既有二级主题时使用。分类时应优先尝试归入前述具体子类，只有在无法匹配时方可使用本类。当帖子虽存在明确求助意图，但内容不符合任何具体子类标准，或同时涉及自闭症及其他疾病的诊断问题、多个问题混杂难以进一步细分，或咨询内容与自闭症无直接相关性时，可归入本类。此外，当问题描述较为泛化或表述混乱，发帖者自身难以明确具体需求时，也可归入本类。

示例记录：

1. “宝宝 牛奶蛋白过敏 . 安敏健 怎么样 . 有点乳糖不耐受”
2. “在之前的工作单位，见过学生突发癫痫，肢体控制不住的那种，几个人摁着，像触电一样。那么，宝宝癫痫什么症状？”

3.3 广告

定义：指以推广产品、课程、服务或机构为主要目的的帖子，包括直接广告（硬广）以及以科普或经验分享形式包装的间接广告（软广）。若发帖者为患者或家属，仅分享个人经历、感受或非营利性互助信息，且未出现引流行为、联系方式、课程安排或价格信息，不应判定为广告。同样，家长自发建群交流自闭症相关经验且不涉及具体产品或服务推广的，不属于广告。本类帖子的核心特征在于以引流、招生、推广课程或服务为目标，通常附带联系方式或行动号召性话术。

关键词：机构名称、康复中心、报名、试听、优惠、加我、微信号、电话、二维码。

示例记录：

1. “××康复中心新开 ABA 课程，扫码即可预约试听，名额有限。”
2. “河北廊坊霸州急招一到两名特教老师，待遇进来看”

3.4 表意不明

定义：指帖子内容不可理解或信息不完整，即使出现关键词，也与自闭症、相关机构或主题无直接关联（若涉及自闭症相关词汇则不归入本类）。本类不包括因技术性缺失（如数据抓取错误）导致的内容异常。此类帖子通常为正常发帖行为，但发帖内容语义不明确，可能包含无法访问的链接、碎片化语言或缺乏实际信息内容，难以判断其具体主题或意图。

示例记录：

1. “我发表了一篇图片贴，大伙来看看吧~”
2. “打个招呼”

3.5 其他

定义：指内容无法归入上述任何一级或二级类别，或属于极少数、边缘性情形，例如举报帖、贴吧管理事务等。亦包括仅表达情绪崩溃、抱怨或消极言论但不存在明确求助意图的帖子（且不构成“心理支持与情绪求助”类），以及家长建群交流自闭症话题或主动为自闭症群体及家长提供帮助等，但未涉及具体求助、诊断、干预或推广内容的情形。本类帖文文本内容本身可以理解，且不属于技术性缺失。其特点为正常发帖行为，但与本研究所关注的核心主题关联度较低。

示例记录：

1. “这样就可以弄成签名档了吗？”
2. “请关爱自闭症儿童。”

4 春雨医生、好大夫主题分类规则

春雨医生与好大夫在线的数据标注，在百度贴吧“寻求帮助”一级主题下的二级主题体系基础上进行跨平台适配。二级主题的定义、关键词范围与判定逻辑原则上保持一致，不另行设立新的主题类别。

与百度贴吧等开放式社区平台相比，春雨医生与好大夫在线属于结构化医疗问诊平台。其文本内容通常由医生的连续追问与患者的分段回应共同构成，患者

的咨询需求往往并非以完整疑问句一次性呈现，而是分散于多轮问答过程之中。

为保证不同平台之间主题分类结果的可比性，本研究在不改变原有主题定义的前提下，对医疗问诊平台的标注规则进行了针对该类平台咨询情境的补充说明。具体补充规则如下。

4.1 自闭症症状

定义：指患者或家属通过描述儿童或患者的具体行为表现、发育异常或日常反应，向医生咨询这些表现是否异常、是否符合自闭症相关特征，或询问自闭症的典型症状。该类关注的核心在于“行为或表现本身是否异常”，而非正式的诊断流程或检查结果。若文本中明确询问“是否为自闭症”“如何确诊”等涉及诊断判断的问题，即使同时描述了大量症状，也不归入本类，而应归入“自闭症诊断”。在医疗问诊平台中，本类仅在同时满足以下条件时方可使用：文本仅包含行为或发育表现的描述性或提问性咨询（如某个症状是否严重或询问自闭症有哪些症状），未出现“是不是自闭症”“诊断”“确诊”“判断”“属于哪种”等判断性提问，且未提及任何检查、量表或评估结果。

关键词：不说话、不看人等症状的表述，未明确提出诊断等需求、有什么症状

示例记录：

1. “6个大的宝宝，感觉有自闭症，这是蝴蝶手吗？”
2. “我想问问宝宝自闭症有些什么症状？”

4.2 自闭症检查

定义：指患者或家属围绕自闭症相关的检查项目、评估工具或量表结果提出问题，包括是否需要进行某项检查、如何解读检查或量表结果、提供视频或图片请医生协助判断，以及询问检查在诊断过程中的作用。若检查结果仅作为辅助信息，而核心问题在于“是否属于自闭症”，应优先归入“自闭症诊断”。本类关注的重点在于检查或量表本身，包括已完成或准备进行的检查，即使最终目的是确诊，但文本重心在检查手段或结果解释。“自闭症检查”类仅在以下情形下使用：文本的核心问题在于某项检查、量表、视频或结果本身如何理解、是否有必要进行或是否具有可靠性，且未直接要求医生判断是否为自闭症。重点在检查本身，而

非诊断判断或资源推荐。

关键词：检查、量表、ADOS、智测、评估表、测试结果、要不要做检查。

示例记录：

1. “麻烦您看看这几个视频有没有问题？”
2. “基因检查能检测出遗传自闭症吗？”

4.3 自闭症诊断

定义：指患者或家属在已有症状描述的基础上，明确围绕“是否为自闭症”这一核心问题进行判断与咨询，涉及自闭症分型、严重程度、诊断可能性、评估结论、如何判断是否为自闭症、诊断流程或确诊路径等内容，重点在于自闭症的诊断本身。当文本同时涉及症状描述与检查结果，但核心问题聚焦于“是否为自闭症”或“诊断路径”时，应统一归入本类。包括详细记录孩子的行为表现或发展史，希望获得初步判断或诊断路径建议，或在提供某项检查、量表、视频或测试结果作为辅助信息的基础上，请求判断是否构成自闭症诊断。只要文本中出现以下任一情形，即应强制归入“自闭症诊断”类别：明确询问“是否为自闭症”“是否属于自闭症”“是否确诊”“是否可以评价”等判断是否为自闭症的问题；询问诊断流程、诊断标准、严重程度或分型；或使用检查、量表、视频等作为依据，其目的在于判断“是不是自闭症”。

关键词：是不是自闭症、帮忙判断、诊断、怀疑、交流一下、很害怕是不是自闭症、该怎么办。

示例记录：

1. “您看下这个检测结果，现在属于是自闭症吗？”
2. “怎样诊断小孩有自闭症？”

4.4 病因/诱发因素咨询

定义：指用户围绕自闭症的成因、诱发机制或责任归因提出问题，包括遗传因素、孕期或围产期因素、养育方式、环境暴露等。本类的核心关注点在于“为什么会这样”，即探讨自闭症发生的原因或可能的影响因素。凡针对自闭症的病因或诱发因素进行咨询的，均归入本类。

关键词：遗传、是不是我造成的、孕期、早产、疫苗、二胎、家族史。

示例记录：

1. “啥是高危因素？”
2. “自闭症是怀孕时候导致的，还是后天导致的”

4.5 费用与经济负担咨询

定义：指用户围绕自闭症相关的诊断、治疗、康复或长期干预所涉及的经济成本及支付能力提出问题。本类咨询的核心在于费用、资金或经济负担本身，而非比较或咨询具体机构的优劣（如“哪家机构好”等）。凡针对自闭症相关治疗、干预或检查所产生的费用问题进行咨询的，均归入本类。

关键词：费用、贵不贵、花了多少钱、能不能报销、撑不撑得住。

示例记录：

1. “这个做康复训练一般需要多少钱？”
2. “费用怎么算？”

4.6 自闭症干预

定义：指用户围绕自闭症的干预方式、治疗路径、训练方法、实施策略及干预后的预后效果提出咨询，包括专业训练干预方式以及在家庭或日常生活中的实施方案。本类涵盖不同分型、不同严重程度下的干预选择，以及对不同干预方式适配性和效果的比较。此类问题反映发帖者对干预效果及未来发展的关注，本质上属于干预与治疗决策层面的咨询。包括询问具体干预方式、训练方法、是否能够改善或治愈、未来预后如何等问题。但不包括未涉及具体干预方法，仅泛泛询问自闭症发展影响的问题，如“自闭症严不严重”“自闭症会不会影响以后”等。

关键词：ABA、感统训练、语言训练、家庭干预、训练强度、干预、不知道怎么办、康复手段。

示例记录：

1. “自闭症您有什么建议吗，多吃什么 多玩什么 还是怎么样康复？”
2. “现在医院的干预课程还没给我们排上，现在在家里干预引导的话主要做哪些？”

4.7 自闭症资源推荐（评价）

定义：用户围绕自闭症相关的诊断、治疗或康复资源，寻求推荐、比较或评价信息。该资源可以是医疗机构（医院、科室）、具体医生，包括询问挂哪个科室也可以是康复机构或从业人员（如康复老师、语言治疗师、行为分析师等），本质是选择合适的医疗资源降低误诊风险。希望通过他人经验降低选择机构的风险。推荐或评价机构、医院、医生等，涉及到去哪里检查、挂什么科室、检查/诊断/治疗在哪里比较好等强调地点的应归为自闭症资源推荐（评价）。

关键词：机构、医院、医生、老师等推荐、康复中心、靠谱不、有没有坑、费用。

示例记录：

1. “安庆有康复中心吗？”
2. “不知道河东医院那边康复效果如何？”

4.8 其他求助

定义：指帖子存在明确求助意图，但内容不符合任何具体二级子类标准，或同时涉及自闭症及其他疾病的诊断问题、多个问题混杂难以进一步细分，或咨询内容与自闭症无直接相关性。当问题描述较为泛化或表述混乱，发帖者自身难以明确具体需求时，也可归入本类。本类为兜底类别，仅在无法归入其他明确子类时方可使用。需要特别说明的是，凡涉及与自闭症无关的其他检查、诊断或治疗问题，应统一归入“其他求助”。例如，询问“我预约 14 号去复查四维彩超，这一项检查是否可以看出心脏的情况？”等与自闭症无关的医学检查问题，应归入本类。

示例记录：

1. “这个能播放吗？”
2. “四磨汤口服液是大人喝的那种么？”